被照顾得很好之后 · 学习包

三编 · 九章 · 九个学习单元



原书作者：陈晓艳

ISBN 979-8-90690-989-3

第538卷 · US$20.00

先答、带问阅读、再答、讨论、本人修订、迁移与观察。

初答不覆盖；建议待核对；理解、赞同和现实应用分别记录。

本包是配套设计，不是著者原文或已验证训练量表。

在线学习：sdeuniverses.com/books/m/538/agent/learning.html

01 第一章：生迹：老人正在长向哪里

第一章 生迹：老人正在长向哪里

你家里或你见过的老人，有没有被照顾得很周到，却越来越常说“没事”的时候？再带着问读第一章：第一，“生迹”和“需求”差在哪里，为什么它只能在整体生命语境里被感知；第二，失认为什么不是预设的恶，而是新公共管理、风险规避与绩效文化在制度里逐层沉积的壳；第三，交接班时说一句“哪个人和往常不太一样”，为什么是最小的实践入口。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：生迹是“我正在成为谁”的指向性痕迹，不是待满足的需求，也不是偏好排序；失认从操作简化凝固为认识论闭合；刚性需求上的代理正当且必要，应提醒的是心智尚有余力却被需求模型全覆盖的老人；辨认生迹靠追踪运动、交叉校验与“安全失败”规则。失败条件：若交接班的那一句话既不增加记录负担、也不与绩效挂钩，持续数月后照护者对老人变化的辨认并无提高，失认论的实践主张便落空。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与先问：第1单元

02 第二章：残迹：被照料得很好的空无

第二章 残迹：被照料得很好的空无

你有没有过一段被安排得满满当当、什么都不缺，却说不出哪里闷的日子？再带着问读第二章：第一，“残迹”为什么比生迹更深一层，连老人自己都无法事先指认；第二，“善意填充”为什么是一种不施力、不注视、让人感到温暖的新权力；第三，不过问、不填充、痕迹保护三条消极纪律各留下了什么。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：残迹是“未被选中、未被完成、未被记住”却在生命里留下纹理的东西，不可还原为自主性或叙事能力；精准匹配范式是在护理资源紧缺、风险规避与标准化压力下被逼出的；留白不是放任，老人处在无需感知的安全网里。失败条件：本章不接受标准化对照实验式的证伪，只接受长时段个案追踪；若有意留白后，老人那种说不清的枯竭感在一个又一个个案里都没有任何可辨识的变化，本章即被否定。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与先问：第2单元

03 第三章：临床海底：身体的代偿为何被当作故障

第三章 临床海底：身体的代偿为何被当作故障

你或家人有没有遇到过：身体自己想办法扛住了一个问题，却被当成需要纠正的异常？再带着问读第三章：第一，“临床海底”与“指南地壳”各指什么，为什么说这是从老人到病人的同一件事；第二，DRG、支付规则与患者安全运动怎样把地壳焊硬，医生为什么被训练出“排雷式认知”；第三，“偏离说理评审”为什么是一条能听见海底的制度通道，它又怎样可能被重新吞没。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：撤销“正确的诊疗路径存在、可被外部编码”这一先验；代偿是身体已经给出的答案，却被地壳读成故障；脊柱融合术是龙骨案例；与康吉扬、福柯、莫尔、鲍尔、德克尔的逐一对质。失败条件：若一个医疗系统在同等安全与费用约束下引入不作过错推定的偏离说理评审，医生基于判断的偏离率显著上升，且这部分患者的长期综合健康不劣于严格合规的同类患者，本章判断即被推翻。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与先问：第3单元

04 第四章：叙事失权：算法叙事抢在身体之前开口

第四章 叙事失权：算法叙事抢在身体之前开口

你有没有拿到一份检测或风险报告之后，再也没法像从前那样问自己一句“我还好吗”？再带着问读第四章：第一，“栖居叙事”与“算法叙事”各是什么，为什么说这种替代不是异化；第二，风险预警、持续监测、去晕减苦除根三重机制各怎样夺走叙事的初权；第三，为什么任何外部设计的“接引方案”都可能重复它所批判的替代者逻辑。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：替代发生在主体能为自己编织可栖居的身体叙事之前，所以不是统治一个已经完整的主体；“叙事难民”的含义；与异化批判、生命政治、疾病叙事传统、梅洛-庞蒂的分离线；“先问后告”的最小形态。失败条件：若无症状时即接受基因风险预警者，与出现症状后才检测者在自体验叙事密度上无差异，“先占”之说不成立；若先引导说出自身体验再告知风险的一组，自述中的自体验叙事并不更多，本章的实践主张落空。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与先问：第4单元

05 第五章：发生权代管：谁来决定身体的下一个稳态

第五章 发生权代管：谁来决定身体的下一个稳态

你或家人有没有在长期治疗之后，发现自己说不清“不靠药，身体会怎样”？再带着问读第五章：第一，“发生权”和“自愈力”差在哪里；第二，林女士的十二年怎样从暂时托管滑向终身代管；第三，撤回代管的三条原则、一个指数与一个限度各是什么，什么样的反例说明精准医疗“重启”了发生权。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：发生权是生命系统在扰动中自行摸索、生成并稳定一条新平衡路径的资格与能力；代管接管的是“修复成什么样、走哪条路”的裁决权；肺癌靶向治疗与类风湿关节炎生物制剂两条经验线；与伊利奇、福柯、莫尔、自创生、委托代理理论的切割。失败条件：若长期生物制剂治疗中，心率变异性、HPA 轴弹性等并未出现与疾病严重度解耦的纵向下降，或撤回代管后没有失序期、失序期与代管年限无关，本章的核心假说即被削弱。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与先问：第5单元

06 第六章：健康抵押：“我好了”是怎样被押出去的

第六章 健康抵押：“我好了”是怎样被押出去的

你上一次不看任何数字、只凭身体的感觉就确定“我好了”，是什么时候？再带着问读第六章：第一，“健康抵押”指的是哪一笔交易，为什么每一次成功履行都在损耗它宣称要赎回的东西；第二，赫赛汀、BRCA 检测这样真实的成功，怎样被编进对多数人而言永不终结的抵押流程；第三，那块不可估值的飞地为什么不是回到技术之前，而是穿过技术之后的决断。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：控制变量是内感受判断力在个体认知裁决中的征用优先序；逆向置换与让权失败；与伊利奇、福柯、罗斯的分离线；本章不反对测量，反对的是读数在裁决次序中排在当事人的感觉之前。失败条件：若出现一种普及的诊断—监测范式，日常运作不依赖先把内感受判断力宣布为不可靠，且长期追踪显示使用者的身体主权感显著增强，健康抵押机制即被推翻。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与先问：第6单元

07 第七章：致密纠缠：为什么越准越错

第七章 致密纠缠：为什么越准越错

你或家人有没有遇到过：一种药刚开始很灵，后来要越加越多、越换越新？再带着问读第七章：第一，“致密纠缠”的三个判据是什么，为什么被命中的靶心已不是被瞄准的那个对象；第二，高血压、抑郁与肿瘤耐药各是怎样的变形，β受体阻滞剂的初始恶化效应说明了什么；第三，“扰动—监测—重稳”与“瞄准—命中—校准”差在哪里。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：替定预设了一个可以被替它定下的固定目标，本章证明这个目标在被命中时就变了；最小费力原则；对“解释即扰动”与“数字孪生”两大反驳的回应；适用边界——结核、单基因病等松耦合领域不在此列，本章不否定降压药、抗抑郁药与靶向药当下的救命价值。失败条件：若在原发性高血压中，隐蔽给药的精准降压能长期稳定控压而不引发任何可测的系统性代偿，撤药后也无超出单纯停药的反弹，本章论断即告失效。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与先问：第7单元

08 第八章：溃散之后：把判准还给生命

第八章 溃散之后：把判准还给生命

你有没有经历过一段身体或生活彻底散架的时候，后来是怎样重新过下去的，那个“过下去”的样子是谁定的？再带着问读第八章：第一，三级批判共享的那块地砖是什么，为什么“守护者知道正确的秩序”这一先验要被撤销；第二，“溃散后自组织验”怎样判定健康，为什么它只能事后追溯；第三，四种病程（成功、失败、不体面、成功了一半）各说明了什么。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：健康是生命在溃散后自行重组出任何可维持秩序的发生，不是回到预写剧本；与康吉扬规范能力、图姆斯、安东诺夫斯基、埃德尔曼的分离线；本章不是新临床规程，只是松动认知语法，必要监测、可撤销的安全网与不可逆损伤时的干预义务不免除。失败条件：若一个满足“未被强加范本、系统自行摸索出可维持秩序”的案例，本判准并不能比现有框架给出更多的辨别力；或外部支持强度与自组织成功率的关系是单调上升而非倒 U 形，本章即站不住。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与先问：第8单元

09 第九章：位置性存有：什么都长不出时，他仍占着一个位子

第九章 位置性存有：什么都长不出时，他仍占着一个位子

如果你照护过一位已经认不出你的亲人，你有没有问过自己：我做的这些，他都感觉不到，还有什么意义？再带着问读第九章：第一，“位置性存有”为什么不依赖任何能力、记忆与身份；第二，列维纳斯的“面孔”、海德格尔的“此在”、安提戈涅的无条件义务为什么在这里同时失效；第三，为什么说照护行为的道德分量不在被感知，而在发生。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：智慧养老在最善意的运作中把失智老人从“人”的位子上拂去；位置性存有在逻辑上优先于“善”与“美”；被捧起的灰与照护机构里一块砖一块砖重新砌起的位子；“先承认，后服务”。失败条件：若神经科学证明晚期失智者在深层仍感知并回应尊重或轻视，本章与三大传统的划界需重审；若跨文化研究显示这只是特定文化的伦理直觉，普适性主张降调；若以在场者身份称呼、告知的频次与激越、拒食等指标毫无关联，本章需要更强的论证。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与先问：第9单元